

25/9/2025

Annonce d 'une maladie grave

Pr Rabah Aicha
Oncologie Médicale
CHU Oran/Universite Ahmed Ben Bella –Oran 1
rabah_a2002@yahoo.fr

Plan du cours

I-Objectifs pédagogiques

II- Introduction

III-Définitions

IV-Retentissement de l'annonce

V-Les mécanismes de défense

- Patients
- Soignants

VI-Processus d'annonce

- Lieu
- Moment
- Participants et par qui ?
- Comment
- Les erreurs

VII-Conclusion

I-Objectifs pédagogiques

- Définir une **maladie grave**
- Connaître différents types de « **systèmes de défense** »
- Connaître le **processus d'annonce** : quand , comment , ou
- Moment fort de la **relation de confiance** entre soignants et patient.

II- Introduction

- Parmi les **défis** de la pratique de la médecine c'est annoncer à un patient et à ses proches une maladie grave, voire mortelle.
- Important : connaissances sur les réactions habituelles des patients dans de telles circonstances
- L'annonce d'une maladie grave constitue **un traumatisme** pour le patient.
- L'annonce est donc un **temps essentiel**, : La bonne **adhésion** du patient aux traitements qui lui sont proposés – et adaptés avec lui – s'inscrit dans ce processus de réorganisation de sa vie
- « **Il n'existe pas de "bonnes" façons d'annoncer une mauvaise nouvelle mais certaines sont moins dévastatrices que d'autres** »

III- Définitions

- A condition that carries a high risk of mortality, negatively impacts quality of life and daily function, and/or is burdensome in symptoms, treatments, or caregiver stress. *Serious illness can also be referred to as severe illness.*

Kelley AS. J Palliat Med. 2014 Sep;17(9):985.

- Une « **maladie grave** » est un problème de santé qui comporte un risque élevé de mortalité ET qui a un impact négatif sur le fonctionnement quotidien ou la qualité de vie d'une personne.

Elle met en jeu le **prognostic vital**

- Maladie ou état où **la mort** est **possible ou** imminente.

III- Définitions

« **Pronostic** » = savoir d'avance, prévoir, estimer (jamais une certitude)

c'est la prédiction concernant **l'évolution d'une maladie** (guérison, aggravation, rechute, décès) .

Vital (survie)

Fonctionnel (chances de récupération ou séquelles)

Evolutif

III- Définitions

Quelles sont les maladies graves et redoutées ?

- Les maladies cardiovasculaires (accidents vasculaires cardiaques ou cérébraux)
- Les cancers à pronostic réservé .
- Les maladies cardiovasculaires graves (insuffisance cardiaque terminale, infarctus du myocarde compliqué)
- Le diabète (complications)
- La maladie d'Alzheimer
- La maladie de Parkinson

Sont responsables de 80 % des décès prématurés dans le monde.

III- Définitions maladie chronique

- **Affection de longue durée qui, en règle générale, évoluent lentement.**
- Certaines ne sont pas des maladies graves dans la mesure où elles modifient peu l'espérance de vie.
- Altérations : dimensions psychologique, sociale et économique dans la vie d'une personne

III- Définitions

Annonce

- **Entretien** destiné à informer le patient d'un
 - ☐ D'informer le patient sur sa maladie.
 - ☐ De l'informer sur les alternatives thérapeutiques.

Annoncer c'est

- Communiquer
- Faire savoir
- Faire comprendre
- l'étape de l'annonce diagnostique représente **un moment important** à saisir, parce que **déterminant pour la suite.**

Consultation est souvent longue ce qui permet un réel dialogue entre le patient, ses proches et le médecin.

Pourquoi annoncer ??

- Obligation morale et légale: droit du patient à l'information sur sa maladie.
- Donner au praticien les outils de travail: information, communication dans telles situations.
- Faciliter au patient le travail de deuil de l'état de santé antérieure.

IV-Retentissement de l'annonce

- Il s'agit d'un **traumatisme** pouvant mener à un état de **sidération** ; la qualité de la rencontre permettra de créer un cadre favorisant la sortie de ce traumatisme.
- Ce qui est pour le praticien un moment éprouvant représente pour son interlocuteur un instant où toute sa vie bascule

« Comme si le ciel m'était tombé sur la tête »

- Les différentes étapes du processus d'acceptation :

Le choc,

La colère

Le marchandage

La dépression,

L'acceptation.

V- Les mécanismes de défense

- 1- Patients :

Processus psychiques inconscients qui se mettent en place pour préserver le sujet d'une réalité qu'il ne peut entendre.

- **L'isolation** : (non réaction) permet à un patient d'arriver à évoquer ce qui lui arrive sans s'effondrer. Exemple : Mme A. reprend les explications précédemment fournies par le médecin, elle explique très clairement l'évolutivité de sa maladie et la mort inéluctable sans manifester aucune angoisse. Transitoire le temps d'intégrer la gravité l'annonce
- **Le déplacement** : Exemple : Patiente avec cancer du sein métastatique osseuse évoque sa difficulté de marcher, **la charge affective** est déplacée d'une représentation sur une autre, généralement moins menaçante.

V-Les mécanismes de défense

- **La projection agressive** : patient tellement **angoisse** → agressive, colère. « Vous êtes tous *inhumains, incompetents, menteurs..* »
- **La régression** : le patient n 'arrive pas à assumer et demande a une autre personne de prendre la charge exp epoux, fils ,,,,,
- **Le déni** : le patient se comporte comme si rien ne lui avait été dit, peut être partiel et transitoire et par fois peut durer. (refus : conscient ou inconscient d'accepter)

Etapes de l'acceptation de la maladie

Modèle de KULER-ROSS

- Le refus , le déni
- La colère (pourquoi moi?, pourquoi maintenant? ..)
- Le marchandage (négociation avec médecins, recherches d'alternatives...) souvent nécessite reconsultation, psychologue
- La dépression (tristesse , pleurs, perte de plaisir, refus de traitement,,,,)
- L'acceptation : dernière étape de ce processus, et la plus essentielle, l'acceptation se traduit par un état de calme où on accepte la maladie comme faisant partie désormais de sa vie.

V-Les mécanismes de défense

2- Soignants :

L'annonce est un moment délicat, redouté souvent, angoissant parfois

L'identification : assez particulier : « Ça ne va pas trop, je suis mal à l'aise avec les patients, j'hésite... »

La fausse réassurance : donner des **faux espoirs**. ⇒ Elle arrive souvent en réponse à l'expression, par le patient, d'une angoisse que le soignant ne se sent pas capable d'entendre.

La fuite en avant : le soignant, soumis à une angoisse imminente, ne trouve pas de solution d'attente et se libère de son savoir, « il dit tout, tout de suite et se décharge de son fardeau. » ⇒ Ne prend absolument pas en compte la nécessité d'une information progressive pour que le patient puisse l'assimiler. Provoque la **sidération** du patient .

V-Les mécanismes de défense

- **La banalisation** Le soignant se focalise sur la maladie et met totalement de côté la souffrance psychique du patient. Exp certains effets secondaires de traitements diabète induit, chute de cheveux ,,,
- **Le mensonge** : pour protéger ou préserve le patient. En réalité, il préserve le médecin, et parfois la famille du malade, de la réaction du patient, telle qu'il l'imagine ou la redoute.

VI-Processus d'annonce

- Lieu
- Moment
- Participant
- Par Qui?
- Comment

Mais avant il faut

- Préparation du dossier :
- Diagnostic confirmé,
- Options thérapeutiques.
- Coordination avec l'équipe soignante

1. Le lieu de l'annonce

- Endroit **calme**, garantissant la **confidentialité** et la **non-interruption** des échanges entre le médecin et le patient (par exemple portables éteints...).
- Ce lieu est dans la mesure du possible **chaleureux**.
- c'est-à-dire permettant un entretien singulier en vis-à-vis et une écoute facilitée (lieu calme, absence de passage, permettant de respecter l'impératif de confidentialité,,,,,,)
- S'asseoir pour parler, **face à face**.
- Patient correctement installé (ne devant pas être dévêtu ..)
- Prendre le temps : entretien spécifiquement consacré à une discussion.

En hospitalisation ou en consultation

2. Le moment de l'annonce

- L'annonce a lieu en semaine.
- Elle ne devrait pas se faire en fin de soirée (minimiser le sentiment d'abandon et de solitude qui suit souvent une telle annonce) ni la veille d'un événement familial pour le patient ,,,
- **Rendez-vous**, si possible, organisé sans mise en scène excessive pour éviter de majorer l'angoisse.
- Dans un **délai acceptable** en tenant compte du fait que, si parfois la prise en charge médicale n'est pas une urgence, celle de la détresse psychique peut l'être.
- Pas trop loin dans le temps.

3. Les participants à l'annonce

- Accompagné d'un proche ou, selon le profil du patient, de la personne la plus adaptée à sa situation. (personne de confiance)
- L'implication du proche, en plus de son soutien moral face à l'annonce, peut s'avérer très utile, l'état de sidération parfois engendré par l'annonce ne permettant pas toujours au patient d'appréhender toutes les informations communiquées par le médecin.
- Laisser au patient le choix d'être seul ou accompagné (professionnel de santé et/ou proche du patient).

4-Par qui?

- Elle doit être réalisée au plus vite par le médecin après qu'il ait pris connaissance des résultats anormaux :
- Médecin spécialiste en imagerie,
- Spécialiste d'organe,
- Médecin traitant ou spécialiste

5-Comment annoncer ??

- **Le savoir-être lors de l'annonce**

« Si aucune recette miracle n'existe pour annoncer une nouvelle grave, il y a des ingrédients indispensables que sont le temps, l'écoute et les mots choisis »

5-Comment annoncer ??

L'annonce implique :

- le choix des **mots**, du **ton** , la **posture** par rapport au patient.
- Il est important d'instaurer une relation **simple** et authentique.
- Il est important d'amener le patient à exprimer **son ressenti** afin de cerner ses besoins spécifiques d'information.
- Rappeler les informations déjà connues du patient comme la raison de cette rencontre, les plaintes ou les difficultés initiales, les examens complémentaires préalablement pratiqués, etc.

5-Comment annoncer ??

- Parler des causes de la maladie et, si c'est le cas, des différentes formes évolutives
- Evoquer les possibilités de recours à différents médecins EXP
 - Intérêt de RCP
 - Second avis : positivée par le médecin.
- Prendre en considération les souhaits et les projets du patient (personnels et professionnels) et de son entourage .
- Proposer si nécessaire d'autres entretiens C'est à partir de l'écoute du patient que le médecin peut adapter son discours et permettre la communication et l'échange..
- La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée.
- Ne pas aborder trop d'informations puisque l'effet traumatique de l'annonce ne lui permettra pas de tout entendre.

5-Comment annoncer

??

- Un **vocabulaire clair**, si possible positif, ou neutre, sans pour autant banaliser le diagnostic.
- Une information simple et progressive
- Une information **répétée, cohérente**, une communication sincère et vraie : ne rien dire qui ne soit vrai.
- Une attention particulière à la formulation, aux mots prononcés, éviter le jargon d'expert.
- Un contrôle régulier de la compréhension et une **reformulation** si nécessaire.

5-Comment annoncer ??

- Le médecin est vigilant sur son langage corporel, évitant que certaines attitudes ou mouvements puissent être sujets à interprétation et n'inquiètent davantage le patient.
- L'utilisation de schémas, dessins ou images peut faciliter la compréhension du patient.
- En fin de consultation, le professionnel s'assure auprès du patient de la **compréhension des informations** données et de la réponse apportée à ses interrogations.
- Citer le nom de la maladie au **temps opportun**

6- Les erreurs à éviter lors de l'annonce

- L'annonce ne doit pas se faire par téléphone, mail ou courrier postal ni la veille d'un week-end ou d'un jour férié.
- Il faut éviter un jargon médical incompréhensible pour le malade ainsi que tout vocabulaire à connotation morbide ou mortifère.
- La dilution des responsabilités : absence d'annonce, un manque de référent, une dilution des responsabilités. absence de soutien.
- L'incohérence des messages transmis : il est important que, face au patient, la parole de l'équipe médicale et soignante soit cohérente.
- Le retard à l'information : une information progressive ne doit pas signifier rétention d'information.
- L'oubli, lors de l'échange, de la principale personne concernée au profit des proches accompagnants.

Quelques exemples de verbatim autour de l'annonce

- Je sais que ce n'est pas facile d'entendre une telle nouvelle quand on ne s'y attend pas.
- J'ai bien peur que nous ayons découvert **des cellules anormales**.
- Je crains d'avoir **une mauvaise nouvelle** à vous annoncer mais il y a des solutions.

LES RÈGLES D'OR DE L'ANNONCE

- Une présentation dès que possible des solutions et des ressources thérapeutiques. un espoir réaliste. Le développement de nouvelles thérapies
- l'accompagnement, à sa qualité de vie, équipe médicale et paramédicale pour l'aider à tenir dans le temps, le parcours pouvant être long et non linéaire
- Le médecin explique la suite du parcours de soins
- Laisser le patient exprimer son ressenti Une aide psychologique et/ou sociale peut être proposée si besoin.
- Les informations du contenu de la consultation (information donnée, formulation, questions, émotions provoquées)→Contenue dans le dossier médical du patient, accessible à l'ensemble des professionnels

Modèle SPIKES

Méthode structurée largement utilisée

- S – Setting : installer le cadre (préparer l'entretien)
- P – Perception : évaluer ce que sait le patient
- I – Invitation : demander le niveau de détail souhaité
- K – Knowledge : annoncer clairement, langage simple (partager l'information)
- E – Emotions : accueillir les réactions
- S – Strategy/Summary : planifier les étapes suivantes

Après l'annonce

- Accompagner le malade
- Proposer l'aide Encourager les ressources personnelles de défense
du malade : famille+++
- Aides psychologique spécialisée

Conclusion: points forts

- Moment **clé** du parcours de soins.
- Impact psychologique majeur pour le patient et la famille : Un traumatisme pour le patient→ une **sidération**.
- **La qualité de la rencontre** permet de créer un cadre favorisant la sortie de ce traumatisme.
- Respect de la dignité et de l'intimité
- Droit à l'information et consentement éclairé.
- Il existe des **mécanismes de défense**, du côté du malade qu'ils protègent, du côté du médecin, qu'il doit apprendre à reconnaître.
- L'importance du non-verbal, choix des mots, être attentif à l'autre et à ses propres réactions.
- Cohérence de l'équipe de soins.

Les références bibliographiques

- Dispositif d'annonce haute autorité de sante 2019 -cancer-
- <https://doi.org/10.1016/j.revmed.2023.01.007> 0248-8663
- Annoncer une mauvaise nouvelle – HAS
- COMMENT annoncer une mauvaise nouvelle Post'U (2011) 199-204
- LAENNEC N°2/2012 12